

- [Home](#)
- [Fiche prepECN](#)
- [Ma Fiche](#)
- [Consensus](#)
- [Imagerie](#)
- [Discussion](#)

Item 313: Epistaxis (avec le traitement)

27 décembre, 2010

Objectifs CNCI

- Devant un épistaxis, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents
- Identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge

Recommandations

Mots-clés / Tiroirs

NPO / PMZ

- Polycopié national: [item 313](#)

- Unilatéral: local (trauma / tumeur/ inf)
- Bilatéral: général (AVK / HTA / coag.)
- Gpe-Rh-RAI si épistaxis abondante
- 0: calmer / arrêt AVK +/- hospitaliser
- 1: mouchage efficace / compression
- 2: méchage: tamponnement antérieur
- 3: sonde double-ballonnet (AP) / ABP
- 4: embolisation (SP) ou ligature (Eth)
- Si anémie: supplémentation martiale

- Médicaments: AVK / aspirine
- Signes de gravité: hémorragie
- Aucun ex. ne doit retarder le Tt
- Arrêt des AVK +/- relais HNF
- Embolisation ssi hémD stable
- Tt étiologique: Cs ORL / rhino.

- Généralités

- Définition
 - une épistaxis = hémorragie de sang rouge provenant des fosses nasales
 - !! fréquent et bénin mais toujours une urgence médico-chirurgicale
- Anatomie: vascularisation des fosses nasales par 2 systèmes
 - carotide externe → artères sphéno-palatines (partie inférieure des fosses)
 - carotide interne → artères ethmoïdales (partie supérieure des fosses)
 - anastomoses nombreuses: à la tâche vasculaire de Kisselbach ++

- Etiologies

- Epistaxis unilatérale = causes loco-régionales ++
 - Tâche vasculaire: grattage, irritation..(90% !)
 - Traumatique: fracture (cf [item 201](#)) / post-chirurgical
 - Infectieuse: sinusite / rhinopharyngite (cf [item 90](#))
 - Tumorales: fibrome naso-pharyngé +++ / UNCT (cf [item 145](#))
 - Toxique: cocaïne
- Epistaxis bilatérale = causes générales ++
 - Iatrogène: surdosage des anti-coagulants (**AVK**) (cf [item 182](#))
 - Poussée hypertensive: **HTA**: crise aiguë hypertensive (cf [item 130](#))
 - Troubles de la coagulation: thrombopénie / thrombopathie (cf [item 339](#))
 - Granulomatose de Wegener: cf [item 116](#)
 - Maladie de Rendu-Osler
 - = téléangiectasies hémorragiques héréditaires (THH) (T° AD)
 - Téléangiectasies cutanées (péri-buccales ++) et muqueuses
 - Mais aussi viscérales (hépatiques / pulmonaires / digestives)

- Diagnostic

- Examen clinique
 - Interrogatoire
 - Terrain: **HTA** / troubles de l'hémostase / exposition professionnelle (bois)
 - Prises: anti-thrombotiques: **AVK**, aspirine (PMZ) / toxique (cocaïne)
 - Anamnèse: facteur déclenchant / **traumatisme** / échec d'un traitement initial
 - Signes fonctionnels
 - Caractériser l'épistaxis: durée / aspect / **abondance** / uni ou bilatérale
 - Rechercher des signes associés: signes d'HTA / douleur
 - Examen physique
 - Prise des constantes: **PA-FC** / FR-SpO2 / T.
 - Examen ORL: diagnostic positif
 - abaisse-langue: rechercher une épistaxis postérieure
 - **rhinoscopie** +++ : localise le siège (antérieur ou postérieur) +/- la cause
 - Evaluation du retentissement: signes de gravité (PMZ)
 - syndrome anémique: **pâleur** / tachycardie / sueurs / dyspnée
 - choc hémorragique: marbrures / collapsus / oligurie / ↑ TRC
 - autres localisations hémorragiques: gynéco / digestif / hématurie
- Examens complémentaires
 - AUCUN ne doit retarder le Tt: urgence médico-chirurgicale (PMZ)
 - Si épistaxis bénigne: pas d'examen paraclinique nécessaire
 - Si épistaxis abondante:
 - Pour retentissement: NFS-Plaquettes / TP-TCA / **INR** si AVK
 - Bilan pré-transfusionnel: **Groupe-Rh-RAI** (2 prélèvements)
 - !! NPO au décours: bilan étiologique (PMZ)
 - Consultation ORL / fibroscopie nasale: à la recherche d'une cause locale

- Traitement (5)

- 0. Mise en condition
 - **Calmer** le patient / rassurer / installer au calme +/- anxiolytique
 - Hospitalisation dès que épistaxis abondante ou terrain fragile +++
 - !! NPO **ARRET** des AVK et relais par héparine IVSE si besoin (PMZ)
- 1. Mouchage efficace et compression bi-digitale
 - Mouchage efficace pour évacuer les caillots (sinon échec du méchage)
 - Compression bi-digitale simple des ailes du nez en attendant le méchage
- 2. Méchage = tamponnement antérieur
 - Anesthésie locale de contact + vasoconstricteur = **xylocaïne-naphtazolinée**
 - Mèches non résorbables (Algostéril®) ou résorbables si AVK (Surgicel®)
 - **ABP** le temps du méchage (si durée > 48h donc mèches résorbables ++)
- 3. Sonde à double ballonnet = tamponnement antéro-postérieur
 - Si échec du méchage antérieur ou d'emblée en cas de signes de gravité
 - Unilatéral ou bilatéral (1 côté si possible) / gonfler avec du sérum phy
 - !! Si des deux côté: dégonfler toutes les 6h (risque de nécrose locale)
 - **ABP** systématique le temps du méchage (Augmentin®)
- 4. Si échec: selon les possibilités locales: 2 options (associer ++)
- !! dans tous les cas: seulement si patient hémodynamiquement stable (PMZ)
- Tt en radiologie interventionnelle: embolisation
 - artériographie sous AG / embolisation des a. **sphéno-palatines** (carotide externe)
 - !! embolisation des a. ethmoïdales formellement contre-indiqué (carotide interne)
- Tt chirurgical sous rhinoscopie: ligature artérielle
 - ligature des a. **ethmoïdales** (car pas d'embolisation) +/- a. sphéno-palatines
- 5. Au décours: traitement étiologique +++
 - **Cautérisation** si saignement de la tâche vasculaire (épistaxis bénigne du sujet jeune)
 - Education du patient si AVK / Loxen® si HTA / embolisation puis exérèse si fibrome
 - **Consultation ORL** et rhinoscopie indispensable au décours devant toute épistaxis (PMZ)
 - !! Remarque: NPO **fer** si épistaxis abondante: prévenir une anémie ++ (cf [item 222](#))

[A propos](#) - [Conditions Générales de Ventes](#) - [Informations Légales](#) - [F.A.Q](#) - [Nous contacter](#)

Copyright © 2011 prepECN, all rights reserved - Powered by Allworldregister.info

chargement